Бенца Т. М.
доктор медичних наук, професор
Денова Л. Д.
асистент кафедри терапії
Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
м. Київ, Україна

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ ЗАГОСТРЕННЯ ХРОНІЧНОГО БРОНХІТУ У ХВОРИХ ІЗ СУПУТНІМИ ХРОНІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

На сьогоднішній день є актуальним питання щодо вибору правильної тактики лікування загострення хронічного необструктивного бронхіту у хворих із супутніми захворюваннями, такими як ішемічна хвороба серця (ІХС), гіпертонічна хвороба (ГХ), цукровий діабет (ЦД).

Згідно визначення ВООЗ, хронічний бронхіт (ХБ) – дифузне запальне ураження бронхів, яке характеризується морфологічною перебудовою слизової і появою харкотиння протягом не менше 2-х років і перебігом не менше 3-х місяців в році [6].

Інфекційну природу загострення ХБ можна вважати доведеною при наявності наступних критеріїв, так званих трьох «вініпегських критеріїв»: посилення кашлю, збільшення кількості відділяємого харкотиння, зміни характеру харкотиння на гнійний; поява або посилення ознак дихальної недостатності (від незначної задишки, не завжди поміченої пацієнтом, до тяжких порушень вентиляції, які вимагають інтенсивної терапії). Підставою для призначення антибіотиків є наявність клінічних і рентгенологічних ознак активності бронхолегеневого процесу, а також виявлення в посіві з харкотиння більше 100000 мікробних тіл в 1 мкл секрету [4].

Основна мета антибактеріальної терапії при загостреннях ХБ – ерадикація збудника (або збудників). Вибір антибактеріального препарату (АП) має здійснюватися з урахуванням активності АП по відношенню до найбільш ймовірних збудників інфекційного загострення ХБ; активністю по відношенню до штамів мікроорганізмів, резистентних до бета-лактамів і макролідів; урахування можливої антибіотикорезистентності в даній ситуації; оптимальної фармокінетика препарату (біодоступність: проникнення в харкотиння і в бронхіальний секрет; час напіввиведення, шляхи елімінаціїї); відсутності або мінімальної взаємодії з іншими ліками; оптимального режиму дозування; безпеки і мінімальних побічних ефектів; вартості пре-

парату із врахуванням показника вартість/ефективність. Також враховуються фактори ризику розвитку резистентності і чутливості до антибіотиків в різних регіонах [2].

За останні роки зібрано чимало даних про розвиток резистентності збудників до пеніциліну в поєднанні зі зниженням чутливості до інших антибіотиків, а саме: макролідів, цефалоспоринів, тетрациклінів і триметоприм/сульфометоксазолу. Фактори ризику розвитку пеніцилінорезистентності включають: вік до 7 і після 60 років, супутню патологію (серцева недостатність, цукровий діабет, захворювання печінки і нирок), попередню антибіотикотерапію, погані побутові умови [1].

Експертами Американського торокального і Європейського респіраторного товариств (1995) допускається у випадках частих повторних загострень ХБ застосування антибіотиків у зимовий час з профілактичною метою [8].

З метою призначення оптимальної антибактеріальної терапії при загостренні ХБ запропоновано враховувати наступні основні ознаки: вік, кількість загострень протягом року, наявність фонової патології; ознаки і вираженість бронхіальної обструкції [2].

У 2007 р. Siempos et al. провели метааналіз порівняльних досліджень застосування амоксицилін/клавуланату, респіраторних фторхінолонів та макролідів при загостренні хронічного бронхіту і зробили висновок, що ці препарати можна вважати еквівалентними для лікування пацієнтів із бактеріальним загостренням хронічного бронхіту [5].

Важливим фактором вибору антибактеріального препарату є наявність побічних ефектів. Амоксицилін/клавуланат зазвичай добре переноситься. Найбільш часто з побічних ефектів спостерігаються розлади з боку шлунково-кишкового тракту, у першу чергу – діарея (до 24%), виникнення якої пов’язують з дією клавуланової кислоти [1].

У сучасних умовах накопичений великий досвід клінічного застосування кларитроміцину при лікуванні позалікарняних інфекцій верхніх і нижніх дихальних шляхів. Кларитромицин має широкий спектр антимікробної активності, який охоплює грампозитивні та грамнегативні бактерії, атипові мікроорганізми та деякі анаероби. У багатоцентрових дослідженнях було доведено, що при призначенні кларитроміцину по 250-500 мг 2 рази на добу (не менше 5 днів) клінічний ефект при гострому бронхіті спостерігався у 97-99%, при загостренні хронічного бронхіту – в 94-96% випадків [2, 7].

По зведеним даним, у цілому переносимість кларитроміцину хороша. Побічні реакції при лікуванні кларитроміцином 4291 хворих зустрічались

у 19,6%, серед яких частіше спостерігались нудота (3%), діарея (3%), диспепсія (2%), біль у животі (2%) і головний біль (2%) [5].

Частота побічних ефектів при застосуванні кларитроміцину і пеніцилінів (пеніцилін, ампіцилін, амоксицилін) при лікуванні позалікарняних інфекцій верхніх і нижніх дихальних шляхів була порівняна (19,3 та 16,3%) [3].

Ефективність лікування може оцінюватись як «клінічне одужання» при зникненні симптомів загострення протягом 21 дня; «клінічне покращення» – при зменшенні задишки, кашлю і кількості відділяємого за добу харкотиння або його гнійного компоненту через 3-5 днів лікування протягом 21 дня; «клінічна неефективність» – при відсутності позитивної динаміки протягом перших 3-5 днів [8].

Мета нашого дослідження: вивчити ефективність антибіотикотерапії, а також дослідити частоту побічних дій у хворих на хронічний необструктивний бронхіт у фазі загострення з супутніми хронічними захворюваннями.

Матеріали і методи: нами обстежено та проліковано 61 хворих з діагнозом – хронічний необструктивний бронхіт у фазі загострення, ДН I ст. та супутніми захворюваннями, таким як: ГХ різного ступеня (1, 2, 3, 4) та різної стадії (I, II, III), ІХС (різні форми: атеросклеротичний або постінфарктний кардіосклероз, стенокардія напруги I-III ФК, СН 0-IIA ст.), ЦД (1 та 2 типів).

I група хворих (28 чол.) отримувала амоксицилін/клавуланат 625 мг кожні 12 год протягом 7 днів. II група хворих (33 чол.) отримувала кларитроміцин 500 мг кожні 12 год протягом 7 днів. Крім того, хворі приймали муколітики (амброксол, бромгексин, ацетилцистеїн), проводилась медикаментозна терапія супутніх захворювань за загальноприйнятими протоколами.

В I групі у 4 пацієнтів (14,3%) виникла необхідність збільшити дозу амоксициліну/клавуланату до 1000 мг; у 2 пацієнтів (7,1%) – замінити амоксицилін/клавуланат на інший антибіотик (ін'єкційний цефтриаксон). У II групі кларитроміцин замінили у 8 пацієнтів (24,2%).

У 18 (64,3%) пацієнтів I групи спостерігались побічні дії амоксициліну/клавуланату (діарея, нудота, блювання та головокружіння), у 26 (78,8%) пацієнтів II групи – побічні дії у вигляді нудоти, блювання, діареї, головного болю.

Транзиторна протеїнурія (0,033-0,066 г/л) була виявлена у 9 (32,1%) хворих з I групи та у 15 хворих (45,5%) з II групи. Також у 5 (17,9%) хворих з I групи та у 8 (24,2%) хворих з II групи зафіксовано гіпертонічний

криз. Підвищення глюкози крові (на 5-8 ммоль/л вище звичайного для хворих рівня) у хворих з ЦД відмічено тільки у 5 (15,2%) хворих II групи.

Висновок: широкий спектр дії у поєднанні із задовільним профілем безпеки дозволяє рекомендувати амоксицилін/клавуланат у якості препарата вибору для емпіричної терапії хворих із загостренням хронічного необструктивного бронхіту та супутніми захворюваннями (ГХ, ІХС, ЦД 1 та 2 типів).

Список літератури:

1. Гучев И.А., Козлов Р.С. Безопасность и эффективность различных лекарственных форм амоксициллина/клавулановой кислоты при инфекциях нижних дыхательных путей у взрослых: открытое проспективное рандомизированное исследование // Пульмонология. – 2008. – №2. – С. 73–80.
2. Дворецкий Л.И. Больной с инфекцией нижних дыхательных путей. Ключевые вопросы антибактериальной терапии // РМЖ. – 2013. – №29. – С. 143-149.
3. Рачина С.А., Зайцев А.А. Фармакоэпидемиологические исследования антибактериальных препаратов при внебольничных инфекциях дыхательных путей / глава в книге: Внебольничные инфекции дыхательных путей: диагностика и лечение / руководство для врачей. – Москва: ООО «М–Вести», 2008. – С. 254–271.
4. Скворцов В.В., Орлов О.В. Диагностика и лечение хронического необструктивного бронхита // Поликлиника. – 2010. – №5. – С. 88-91.
5. Siempos I., Dimopoulos G., Korbila I., Manta K., Falagas M. Macrolides, quinolones and amoxicillin/clavulanate for chronic bronchitis: a meta–analysis // Eur. Respir. J. – 2007. – 29: 1127–1137.
6. Електронний ресурс: diagnostichouse.ru/bronxit/973-antibiotiki-pri-xronicheskom-bronxite.html.
7. Електронний ресурс: www.medcentre.com.ua/articles/Mesto-antibakterialnoy-terapii-v-37499.
8. Електронний ресурс: www.nedug.ru/lib/lit/therap/01oct/therap.htm.